PROTOCOLO CLÍNICO DE MANEJO TERAPÉUTICO, FARMACOLÓGICO Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR SECUNDARIA

Sociedad Europea de Cardiología (ESC) / Organización Mundial de la Salud (OMS)

Documento de Consenso: ESC-OMS-PREV-2024

Área de Especialidad: Farmacoterapia Cardiovascular, Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria

---

1. Principios del Tratamiento Integral de la Cardiopatía Isquémica

El manejo de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad coronaria (presencia de estenosis luminal ≥ 50%, antecedentes de síndrome coronario agudo o diagnóstico positivo `target ≥ 1` en el score clínico) se fundamenta en tres pilares: alivio sintomático de la angina, prevención de eventos aterotrombóticos recurrentes y reducción de la mortalidad por todas las causas.

---

2. Metas Hemodinámicas y Metabólicas en Prevención Secundaria

2.1. Control Tensional Estricto

- **Meta General:** Presión arterial en reposo `< 130/80 mmHg`, siempre que sea tolerada clínicamente sin hipotensión ortostática sintomática.
- **Adultos Mayores (≥ 65 años):** Mantener PAS entre 130-139 mmHg para asegurar una adecuada presión de perfusión coronaria y cerebral.

2.2. Optimización Lipídica Agresiva

- **Meta de Colesterol LDL (c-LDL):**
- Reducción $\ge 50\%$ respecto al valor basal y alcanzar un c-LDL absoluto `< 55 mg/dL` (1.4 mmol/L) en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular.
- Para pacientes de alto riesgo: c-LDL `< 70 mg/dL` (1.8 mmol/L).
- **Colesterol Total (Chol):** Mantener niveles plasmáticos de colesterol total inferiores a `150-175 mg/dL`.

2.3. Control Glicémico y Metabólico

- Pacientes con glucemia alterada en ayunas (`fbs > 120 mg/dL`) o diabetes mellitus establecida:
- Meta de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) `< 7.0%`.
- Preferencia por fármacos con beneficio cardiovascular demostrado (inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1).

---

3. Esquemas Farmacológicos Estandarizados

3.1. Terapia Antiagregante Plaquetaria

1. **Ácido Acetilsalicílico (AAS):** Dosis de mantenimiento de 75 a 100 mg diarios vía oral de forma indefinida en todos los pacientes con cardiopatía isquémica documentada.
2. **Doble Antiagregación Plaquetaria (DAPT):**

- Indicada tras angioplastia coronaria con stent medicado o síndrome coronario agudo.
- Combinación de AAS (81-100 mg/día) con un inhibidor potente del receptor P2Y12:
- **Ticagrelor:** 90 mg cada 12 horas, o
- **Prasugrel:** 10 mg cada 24 horas (ajustar a 5 mg en ancianos o peso < 60 kg), o
- **Clopidogrel:** 75 mg cada 24 horas si existen contraindicaciones para ticagrelor/prasugrel.
- Duración estándar: 6 a 12 meses, individualizando según el balance entre riesgo isquémico y riesgo de sangrado (Score PRECISE-DAPT).

3.2. Hipolipemiantes de Alta Intensidad

- **Estatinas de Alta Potencia:** Atorvastatina 40-80 mg/día o Rosuvastatina 20-40 mg/día.
- **Terapia Combinada:** Si no se alcanza la meta de c-LDL con la dosis máxima tolerada de estatina, adicionar Ezetimiba 10 mg/día. En pacientes refractarios, considerar inhibidores de PCSK9 (Evolocumab o Alirocumab).

3.3. Betabloqueadores y Moduladores Neurohormonales

- **Betabloqueadores cardioselectivos:** Bisoprolol (2.5 - 10 mg/día), Metoprolol succinato (50 - 200 mg/día) o Carvedilol (6.25 - 50 mg/día).
- Indicados especialmente en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, disfunción ventricular izquierda (FEVI ≤ 40%) o síntomas anginosos recurrentes inducidos por ejercicio.
- Objetivo terapéutico: mantener una frecuencia cardíaca en reposo entre `55 y 60 lpm`.
- **Inhibidores de la ECA (IECA) / Antagonistas del Receptor de Angiotensina II (ARA-II):** Enalapril, Ramipril, Losartán o Valsartán en presencia de HTA, FEVI deprimida, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica.

---

4. Algoritmo de Acción ante Sospecha de Síndrome Coronario Agudo (SCA)

1. **Atención Prehospitalaria Inmediata:** Ante dolor torácico retroesternal opresivo > 20 minutos con irradiación típica (Angina Tipo 1) y signos de bajo gasto cardíaco:

- Administrar 300 mg de AAS masticable.
- Monitorización electrocardiográfica continua y toma de ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos desde el primer contacto médico.

2. **Estratificación por Biomarcadores y ECG:**

- Si se evidencia elevación del segmento ST persistente en 2 derivaciones contiguas: activar código infarto para angioplastia primaria inmediata (tiempo puerta-balón < 90 minutos).
- Si no hay elevación de ST (SCASEST): dosificar troponina cardíaca de alta sensibilidad (0h / 1h o 0h / 2h) y calcular score GRACE para definir estrategia invasiva temprana (< 24h) o diferida.